

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5092636-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: JULIANE GONCALVES CABRAL

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. DIAGNÓSTICO DE NEUROMIELITE ÓPTICA. MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELO CEAF PARA DOENÇA DIVERSA À DA AUTORA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS OFERECIDOS PELO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE. TEMA 793 DO STF. CUMPRIMENTO DIRECIONADO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando que os réus forneçam à parte autora o medicamento rituximabe 500 mg, nos termos da prescrição médica dos autos. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5092636-85.2024.4.02.5101

510015037890 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5092636-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: JULIANE GONCALVES CABRAL

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão do juízo de origem que negou a tutela de urgência, nos seguintes termos:

" (...)

Por outro lado, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 106), fixou a seguinte tese quanto a medicamentos não incorporados ao SUS:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

Ressalte-se, inclusive, que, após o julgamento dos embargos de declaração, restou plenamente assentado que é vedada, na forma do art. 19-T da Lei nº 8.080/90, a utilização off-label de medicamentos, isto é, "aquele em que o medicamento é utilizado no tratamento de patologias não autorizado pela agência governamental e, por conseguinte, não se encontra indicado na bula" (voto proferido pelo Min. Benedito Gonçalves no julgamento dos EDcl no REsp nº 1.657.156/RJ).

O entendimento possui caráter vinculante, na forma do art. 927, inciso III, do CPC, ao prescrever que os juízes e tribunais observarão "os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos", de modo que cabe analisar a presença dos requisitos acima descritos para fins de análise do pleito. Saliente-se, ademais, que a modulação dos efeitos do julgado apenas atinge o caráter vinculante da decisão, sendo certo que constatações de veras semelhantes foram adotadas pelo STF no julgamento da STA 175, Rel. Min. Gilmar Mendes.

No caso concreto, de acordo com o laudo emitido pelo médico assistente da autora, a mesma recebeu o diagnóstico de neuromielite óptica (NMO), em 2019, sendo indicado o uso do medicamento Rituximabe 500mg, na dose de 1g a cada seis meses.

O parecer do NAT apresentado no evento 31 informa que o medicamento pleiteado **não apresenta indicação em bula** para o tratamento da doença da requerente, e que sua indicação configura uso *off label*. Afirma, ainda, que, atualmente, não há autorização excepcional pela ANVISA para o uso *off label* do medicamento Rituximabe no tratamento da mielite transversa e neuromielite óptica.

Nesse caso, vale reiterar que o STJ, na decisão que acolheu os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 1.657.156, modificou o acórdão do recurso repetitivo, trocando a expressão “existência de registro na ANVISA” para “**existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência**” (grifei).

De acordo com o voto do Exmo. Ministro Relator Benedito Gonçalves, a existência de registro na ANVISA e do uso dentro das especificações aprovadas pela agência reguladora é medida que visa proteger o usuário do sistema de saúde, pois estes medicamentos foram submetidos a estudos clínicos que comprovaram sua qualidade, sua efetividade e sua segurança. Busca-se, portanto, evitar que o sistema público seja obrigado a fornecer medicamentos que, devidamente registrados, tenham sido indicados para utilizações *off label* que não sejam reconhecidas pela ANVISA nem mesmo em caráter excepcional.

Assim, em análise preliminar, considerando que o uso do medicamento pleiteado não é autorizado para tratamento da enfermidade da parte autora e, ainda, sendo necessário demonstrar a eficácia do fármaco em questão para a doença da demandante, é imprescindível a dilação probatória, de modo a justificar o indeferimento da tutela de urgência ora pretendida.

III - Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida.”

Em seu recurso, a DPU esclarece que a parte autora não vem apresentando resultados eficazes com o medicamento azatioprina e que o rituximabe vem sendo amplamente utilizado em casos de neuromielite óptica, sendo considerado eficaz para o tratamento da fase crônica da doença.

Liminar deferida no Evento 5.

VOTO

Inicialmente, ressalto que em relação à competência, não será aplicado o tema 1234, em razão da modulação do efeitos ali estabelecida, eis que a demanda originária foi ajuizada antes de 11/10/2024:

“ (...) I. **COMPETÊNCIA** 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

(...)

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”

De acordo com o formulário médico anexado aos autos, a parte autora é portadora de neuromielite óptica, já realizou tratamentos com metilprednisolona e plasmáfereze, bem como azatioprina como terapia de manutenção. Contudo, esta última tem apresentado mielotoxicidade com anemia significativa. Necesita do medicamento Rituximabe, 1 grama a cada 6 meses por tempo indeterminado (evento 1, ANEXO3 pag.6/7)

De acordo com o NAT, o medicamento possui registro na ANVISA mas não para a patologia da Autora. Apesar de se tratar de uso *off label* de medicamento, afirma existir evidência científica para o uso do Rituximabe no tratamento da neuromielite óptica (evento 31, PARECER1)

De acordo com literatura consultada, em relação ao tratamento do distúrbio do espectro da **neuromielite óptica** (NMOSD), divide-se em fase aguda e fase crônica, sendo em fase aguda recomendado tratamento mais precoce possível a fim de possibilitar maior redução de déficits permanentes. Como tratamento de fase aguda, recomenda-se o uso de pulsoterapia com altas doses de corticoterapia endovenosa (**Metilprednisolona**) realizando desmame progressivo após, e por via oral com corticóides durante cerca de 6 (seis) meses. Em caso de pacientes refratários a corticoterapia endovenosa, é recomendada segunda linha de tratamento pelo uso de **Plasmáfereze** (PLEX). Em pacientes ainda refratários ao uso de PLEX, sugere-se, então, a possibilidade de uso de **Imunoglobulina Humana** endovenosa. Para o tratamento de fase crônica, mais uma vez se faz necessário diferenciar de quadro de EM. Recomenda-se, o uso de medicações imunossupressoras como, em administração por via oral, **Micofenolato de metila** ou **Azatioprina** e, caso em administração endovenosa, sugere-se o uso de **rituximabe** (Anti-CD20), **sendo tais medicações modificadoras de doença e eficazes em prevenção de novos surtos de crises, seja em pacientes adultos** ou mesmo em faixa pediátrica”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo nº 1.657.156/RJ, fixou a tese da possibilidade de concessão de medicamentos não padronizados no SUS desde que comprovados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- (i) *necessidade do medicamento ou a ineficácia da alternativa terapêutica existente no SUS;*
- (ii) *incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e*
- (iii) *existência de registro na ANVISA do medicamento.*

Ao que se verifica do julgado já mencionado neste voto, o medicamento em uso *off label* não está abarcado pelo entendimento do STJ.

Nesse sentido também o Enunciado 75 do CNJ:

ENUNCIADO Nº 75 *Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios:*

I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial;

II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso *off label* ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA;

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas. (grifos nossos)

Importante destacar que a Anvisa não veda a prescrição de medicamento *off label* e nem a considera incorreta¹. Confira-se:

Como a Anvisa vê o uso *off label* de medicamentos

Cada medicamento registrado no Brasil recebe aprovação da Anvisa para uma ou mais indicações, as quais passam a constar na sua bula, e que são as respaldadas pela Agência. O registro de medicamentos novos é concedido desde que sejam comprovadas a qualidade, a eficácia e a segurança do medicamento, sendo as duas últimas baseadas na avaliação de estudos clínicos realizados para testá-lo para essas indicações.

Quando um medicamento é aprovado para uma determinada indicação isso não implica que esta seja a única possível, e que o medicamento só possa ser usado para ela. Outras indicações podem estar sendo, ou vir a ser estudadas, as quais, submetidas à Anvisa quando terminados os estudos, poderão vir a ser aprovadas e passar a constar da bula. Estudos concluídos ou realizados após a aprovação inicial podem, por exemplo, ampliar o uso do medicamento para outra faixa etária, para uma fase diferente da mesma doença para a qual a indicação foi aprovada, ou para uma outra doença, assim como o uso pode se tornar mais restrito do que inicialmente se aprovou.

Uma vez comercializado o medicamento, enquanto as novas indicações não são aprovadas, seja porque as evidências para tal ainda não estão completas, ou porque a agência reguladora ainda as está avaliando, é possível que um médico já queira prescrever o medicamento para um seu paciente que tenha uma delas. Podem também ocorrer situações de um médico querer tratar pacientes que tenham uma certa condição que, por analogia com outra semelhante, ou por base fisiopatológica, ele acredite possam vir a se beneficiar de um determinado medicamento não aprovado para ela.

Quando o medicamento é empregado nas situações descritas acima está caracterizado o uso *off label* do medicamento, ou seja, o uso não aprovado, que não consta da bula. O uso *off label* de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. Há casos mesmo em que esta indicação nunca será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras cujo tratamento medicamentoso só é respaldado por séries de casos. Tais indicações possivelmente nunca constarão da bula do medicamento porque jamais serão estudadas por ensaios clínicos.

O que é uso *off label* hoje pode vir a ser uso aprovado amanhã, mas nem sempre isso ocorrerá. O que é *off label* hoje, no Brasil, pode já ser uso aprovado em outro país. Não necessariamente o medicamento virá a ser aprovado aqui, embora frequentemente isso vá ocorrer, já que os critérios de aprovação estão cada vez mais harmonizados internacionalmente.

A aprovação no Brasil, porém, pode demorar, por vários motivos, entre os quais o de que o pedido de registro pode ser feito muito mais tarde aqui do que em outros países. Também pode ocorrer que o medicamento receba aprovação acelerada em outro país, baseada na apresentação de estudos preliminares ou incompletos, o que, via de regra, não é aceito pela Anvisa. Por fim, um uso autorizado no Brasil pode ser uso *off label* em outros países.

A classificação de uma indicação como *off label* pode, pois, variar temporalmente e de lugar para lugar. O uso *off label* é, por definição, não autorizado por uma

O CONITEC publicou artigo² sobre o uso *off label*, no qual destaca:

"Além da falta de evidências que explicam por que um medicamento não está registrado no País ou não possui determinada indicação em sua bula, há motivos econômicos muito importantes.

Solicitar a autorização de registro de um medicamento é prerrogativa da empresa produtora. Uma empresa pode desistir de fazê-lo por razões comerciais que vão desde a falta de interesse nesse mercado até acordos entre as empresas compartilhando os nichos de mercado e reduzindo assim a concorrência.

*Sob essa ótica, há que se rever a utilização do termo e desmistificar o uso **off label**, que é muito mais comum do que se imagina ou se registra: o termo deveria ser aplicado apenas para o uso irrestrito e inseguro, quando não há evidências científicas. Quando a ausência de registro se deve a razões de mercado, a incorporação ou prescrição poderá ser feita, desde que cientificamente embasada.* (grifos nossos)

Desse modo, entendo que possuindo registro na ANVISA e existindo evidências científicas que embasem a sua prescrição para a doença que acomete o Autor, o que o NAT confirmou existir, entendo que sim é possível o seu fornecimento pelo Poder Público, até porque não existe alternativa terapêutica no caso em tela, não havendo sequer PCDT, publicado ou em elaboração, para a neuromielite óptica, como também esclarecido pelo NAT:

Ademais, informa-se que este Núcleo não identificou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT¹⁰) publicado¹¹ para **neuromielite óptica** – quadro clínico apresentado pela Autora e, portanto, **não há lista oficial e específica de medicamentos** que possam ser implementados nestas circunstâncias

Acrescenta-se ainda que a **neuromielite óptica (NMO)** é considerada uma doença rara. Epidemiologicamente, a NMOSD é mais prevalente no sexo feminino, com proporção de 3:1 aproximadamente, e possui maior incidência em etnias de asiáticos e negros quando comparada aos caucasianos. Possui distribuição em todo o território mundial, porém, com prevalência rara de 0,3 a 4,4 a cada 1.000 indivíduos e incidência de 0,053 a 0,4 a cada 1.000¹². Assim, cumpre salientar que o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprovando as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do SUS e instituiu incentivos financeiros de custeio. Ficou estabelecido que a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras¹³ tem como objetivo reduzir a mortalidade, contribuir para a redução da morbimortalidade e das manifestações secundárias e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados paliativos.

Ainda de acordo com a referida Política, o Ministério da Saúde ficou responsável por estabelecer, através de PCDT, recomendações de cuidado para tratamento de doenças raras, levando em consideração a incorporação de tecnologias pela CONITEC, de maneira a qualificar o cuidado das pessoas com doenças raras¹⁴. Contudo, reitera-se que **não há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)**¹⁰ publicado para o manejo da **neuromielite óptica**.

Nesse sentido o enunciado 59 do CNJ:

ENUNCIADO Nº 59 As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE.

Desse modo entendo estarem presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, eis que demonstrados a imprescindibilidade do medicamento para controle da evolução da doença, que oferece risco de sequelas neurológicas importante, incapacidade funcional e até morte, como descrito no laudo médico.

Quanto ao tema 793 do STF, vejamos o entendimento vigente na 8ª Turma:

"SAÚDE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO, COM BASE NA TESE 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em recurso onde ente federado alega ilegitimidade passiva, com fulcro na Tese 793 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a atribuição de fornecer medicamento/tratamento é de outro ente federado, vale dizer, a interpretação mais consentânea com a jurisprudência do STF é a de que os cidadãos podem postular a concessão de tais medicamentos de todos os órgãos federados, sendo todos legítimos para a causa, porque fazem parte da relação jurídico-material primária, por força da Constituição Federal, sendo ainda, solidariamente responsáveis, com base no mesmo diploma. O que diz o tema 793 do Supremo Tribunal Federal é que o juiz do cumprimento da sentença irá direcionar o ofício para o devedor principal, em primeiro lugar. Assim, a discussão é se o ente federado é o devedor principal ou não, ou seja, aquele que será oficiado em primeiro lugar para cumprir a obrigação. 8 TR – Sessão de 11/06/2019 – Relator: LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA – Processo: 0190958222017402515102"

Tendo em vista que o medicamento pleiteado encontra-se padronizado no SUS, ainda que para outra patologia, sendo dispensado pelo Estado do Rio de Janeiro, o cumprimento deverá ser direcionado primeiramente a este ente, em respeito ao tema 793 do STF.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando que os réus forneçam à parte autora o medicamento rituximabe 500 mg, nos termos da prescrição médica dos autos. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.

1. [http://antigo.anvisa.gov.br/en_US/resultado-de-busca?](http://antigo.anvisa.gov.br/en_US/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=352702&_101_type=content&_101_grou)

[p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-](http://antigo.anvisa.gov.br/en_US/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=352702&_101_type=content&_101_grou)

[1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=352702&_101_type=content&_101_grou](http://antigo.anvisa.gov.br/en_US/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=352702&_101_type=content&_101_grou)

2. <https://www.scielo.br/j/rsp/a/zLdN6Dfgf5B6wQvR9XNmnGR/?lang=pt>